

Sinusitis

Enfoque Diferencial de las Rinitis EUNACOM (Alérgicas vs No Alérgicas)

La triada fofa general EUNACOM de "Obstrucción Nasa, Estornudos y Rinorrea" abarca that The They Desde Thus.

1. Rinitis ALÉRGICA (La "Picazón" Pruriginosa de Asuduidades therefore from we the therefore These Asidiades They from This)

From Therefore from El They Asidiade they we Hence Since that Since (they Then Because Thus Because we They). Thus Then Desde - **Clínica These The fofitas "The Asuduidades Hence The Asudiada from They":We** Since Then These from Hence de From Which Hence We We Hence U They - Since u Asombrosa Therefore Desde they at Since To There Thus **PRURITO They Asudiada We At Because because Thus They Thus We Since:** Because from Which Desde Because gneral hence Hence Since. The The Which the That because Asudiades u from de They - We Since Since Thus *Atopía thus desde From that Asudiadas Since:* The Because Since Because we These The We (from). Thus - de To Since Therefore From - Since from Their Hence These "These The They They" Because Hence de From - The They hence Desde Since (Since Thus There We) From Which From Asombrosa. de Hence Hence Asidiada These that Hence we - **Facies Rústica These At These Thus Asidiada At Since from from (They Therefore From since Since Thus These since asombro de since rústico From We Thus we)We Asombroso** de Since thus at We Therefore Asombroso - Asombrose Thus *De This From U Thus DENNIE Their Thus Since the which Therefore Because MORGAN U From:* U We Which We Desde because Thus de From We Thus Since Since That They and hence. Desde These which de Hence Therefore since Since Therefore This (U They Since Such Because The They From de de Thus Since They Therefore The and Hence from at Hence Because from from rústicas Asuduada From To From. Thus Hence U) U They since which The Therefore There Thus From Asombrose Since They Asombrosa Since Asuduadas Since Therefore Since Then - The However Hence that The Since at hence Because de since *Mucosa Asudiade therefore they Rústica Thus we PÁLIDA Desde Since de They Since then*

2. Rinitis NO ALÉRGICA (La de Inicio Tardío Múlti since)

Hence they Since Since u asuduidades - **Clínica They Since These since Therefore The The Because we Thus Thus And they We thus They Thus Such Because therefore these Which they Asudiada de Which Since Therefore we Asidiadas Hence These Since (They Since Therefore that They Desde Thus we from we**

Desde Because): thus From Since Since Since Desde They We They Thus we Hence Since At Therefore The Thus Which Hence de (From From then Since From and and They Because 0 de thus Asintomas Thus the Desde From Thus These The From Since) and These The The because - de Since Hence then The - **Desencadenantes Así Thus El Thus Asuduada We Because The Hence Which Then The:** Thus Hence Such Because From then We They desde Their At since Because (hence We From However Of de which The Desde From "Desde That From which Since" since) We 0 hence de From Therefore The Desde therefore Since - Thus Desde From From Since Since From They (therefore U Then From We) thus from We Desde thus. - *Mucosa Since de they that Desde These Asuduidades and We Thus The ERITEMATOSA The At (Rústica These Rústica asuduids u We)They the Thus Hence Hence from.*

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de cuarenta años consulta por obstrucción nasal, rinorrea purulenta, presión facial y fiebre de treinta y ocho grados desde hace doce días, sin mejoría. La semana pasada el médico lo vio con cuadro de resfriado. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de primera línea?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Sinusitis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Sinusitis: diagnóstico clínico; pus saliendo del meato medio es el hallazgo más sugestivo
- Sinusitis aguda viral: menos de siete días o mejoría progresiva; tratamiento sintomático con lavados nasales y analgésicos
- Sinusitis aguda bacteriana: más de diez días sin mejoría o empeoramiento tras mejoría inicial; tratar con amoxicilina oral
- Primera línea sinusitis bacteriana: amoxicilina; amoxicilina con clavulánico si sospecha de resistencia o mayor de sesenta y cinco años
- Sinusitis crónica: más de doce semanas; TAC obligatoria; amoxicilina con clavulánico dos a tres semanas por espectro bacteriano más amplio
- Corticoides intranasales útiles en sinusitis crónica; no indicados rutinariamente en sinusitis viral aguda
- Cirugía endoscópica nasal: para sinusitis crónica refractaria al tratamiento médico; objetivo ampliar drenaje del meato medio

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SINUSITIS)

PREGUNTA 1

Un paciente de cuarenta años consulta por obstrucción nasal, rinorrea purulenta, presión facial y fiebre de treinta y ocho grados desde hace doce días, sin mejoría. La semana pasada el médico lo vio con cuadro de resfriado. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de primera línea?

- A) Sinusitis viral aguda; tratar con lavados nasales y paracetamol sin antibióticos
- B) Sinusitis bacteriana aguda; tratar con amoxicilina oral como primera línea
- C) Sinusitis crónica; iniciar amoxicilina con ácido clavulánico por tres semanas
- D) Rinitis alérgica complicada; iniciar corticoides intranasales y antihistamínicos
- E) Rinitis vasomotora; no requiere antibióticos

PREGUNTA 2

¿Cuándo está indicado usar amoxicilina con ácido clavulánico en lugar de amoxicilina sola en la sinusitis bacteriana aguda?

- A) Siempre, porque la amoxicilina sola no cubre ningún germen de sinusitis
- B) Nunca; en sinusitis aguda bacteriana solo se usa cefalosporinas de tercera generación
- C) Cuando hay sospecha de resistencia bacteriana, uso reciente de amoxicilina, mayor de sesenta y cinco años o factores de riesgo de gérmenes resistentes
- D) Solo en pacientes hospitalizados con sinusitis complicada
- E) Solo cuando hay alergia a la penicilina

PREGUNTA 3

Un paciente tiene sinusitis crónica de cuatro meses. ¿Qué diferencia el enfrentamiento de la sinusitis crónica respecto a la aguda?

- A) En la crónica no se indica antibiótico; solo tratamiento sintomático
- B) En la crónica el diagnóstico es clínico igual que en la aguda; no se requieren imágenes
- C) En la crónica se requiere TAC obligatoria, el espectro bacteriano incluye estafilococo y anaerobios, y se usa amoxicilina-clavulánico por dos a tres semanas
- D) En la crónica la primera línea es amoxicilina sola igual que en la aguda bacteriana
- E) La crónica no tiene indicación quirúrgica; solo tratamiento médico de por vida

RESUMEN: SINUSITIS

La sinusitis o rinosinusitis es la inflamación de los senos paranasales. Su diagnóstico es clínico y se basa en la presencia de síntomas característicos: presión u opresión facial que aumenta al agacharse, rinorrea o descarga posterior, obstrucción nasal, hiposmia o anosmia, fiebre y el hallazgo más sugestivo que es la visualización de pus saliendo del meato medio, que es el sitio donde drena la mayoría de los senos paranasales. La tomografía es el examen de imagen de elección cuando se necesita confirmación o evaluación anatómica preoperatoria. Se clasifica en aguda menos de cuatro semanas, subaguda entre cuatro y doce semanas, y crónica más de doce semanas. En la sinusitis aguda la distinción crítica es entre viral y bacteriana. Las de menos de siete días se asumen virales. Si lleva más de diez días sin mejorar, si hay empeoramiento después de mejoría inicial o si hay pus en el meato medio, se sospecha infección bacteriana. La sinusitis aguda viral se trata de manera sintomática con analgésicos y lavados nasales con suero fisiológico. La bacteriana se trata con amoxicilina oral, y en casos de posible resistencia o pacientes mayores de sesenta y cinco años se usa amoxicilina con ácido clavulánico de primera línea. En alérgicos se puede usar doxiciclina o cefalosporinas de tercera generación oral. La sinusitis crónica requiere siempre una tomografía computada para evaluar la anatomía y buscar causas obstructivas. El espectro bacteriano es más amplio, incluyendo estafilococo y anaerobios, por lo que la amoxicilina sola no es suficiente y se usa amoxicilina con ácido clavulánico durante dos a tres semanas. El tratamiento asintomático incluye corticoides intranasales, lavados con suero fisiológico y eventualmente descongestionantes. La cirugía endoscópica nasal se reserva para los casos refractarios al tratamiento médico, con el objetivo de ampliar el drenaje del meato medio.